

Discovery: archivo personal de salud en Chile

Informe de discovery · 5 de octubre de 2026 · Formato: informe completo de 11 secciones, con cálculo de mercado y ROI

1. Resumen ejecutivo

- **El problema existe y tiene respaldo en fuentes públicas.** En 2025 y 2026 la Superintendencia de Salud emitió resoluciones que sancionan a agentes de ventas de ISAPRE por declaraciones de salud que omitieron preexistencias; en esos casos hubo exclusión de cobertura o término de contrato. Además, una fuente del sector (SUSESO) confirma que el paciente puede pedir copia de su ficha, pero que las instituciones solo deben conservarla 15 años.
- **Ya hay un competidor chileno directo.** Meedika, una app para que el paciente organice y comparta su historial, se lanzó en la App Store el 25 de septiembre de 2024 (fecha inferida del artículo que la reporta). Su propuesta se parece mucho a la etapa A del proyecto.
- **Las apps de este tipo suelen ser gratuitas para el paciente.** Esto presiona la disposición a pagar y obliga a definir el modelo de negocio antes de construir.
- **No encontré evidencia de que blockchain sea necesaria para el primer usuario.** Los proyectos blockchain de salud que hallé (Medicalchain, Patientory) son de la era 2017-2018 y no pude verificar su estado actual.
- **Tamaño de oportunidad.** Una estimación conservadora anclada en la prevalencia de hipertensión da unos 3,8 millones de adultos como mercado alcanzable, y entre 38 mil y 115 mil usuarios a tres años. Con los supuestos ilustrativos del informe, los ingresos por suscripción directa serían del orden de US\$ 0,1 a 0,35 millones por año. No se pudo calcular un ROI completo porque no hay datos de costos.
- **Limitaciones importantes.** No hay perfil de empresa, no se pudo ejecutar la validación contra el canon AJTBD (no está instalado) y no existe investigación primaria con usuarios.

2. Pregunta de investigación y alcance

Pregunta: ¿existe una oportunidad real para un archivo personal de salud, centrado en el paciente, que reúna su historial y le permita compartir de forma selectiva solo lo necesario, con Midnight como posible capa de privacidad?

Alcance: primer usuario = persona que quiere ordenar su propio historial; etapas A (historial consolidado) y B (compartir de forma selectiva). Etapas C (antecedentes familiares) y D (alertas y hoja de ruta) se tratan solo como oportunidad futura. Geografía: Chile, con referencias regionales e internacionales.

Método: el flujo de product discovery se ejecutó de forma secuencial en esta conversación, sin los sub-agentes especializados (no hay ninguno instalado en este entorno, solo las instrucciones del flujo). Las fuentes son búsquedas web públicas.

3. Contexto previo y brechas de información

- **Archivo de investigación previa:** no configurado. Esta es la primera investigación documentada sobre el tema, más allá de lo conversado en el chat y del documento «Qué queremos hacer».
- **Conocimiento del producto y datos internos:** no aplican; el producto aún no existe y no hay perfil de empresa.
- **Brecha:** la evaluación de ajuste estratégico no se ejecutó y el nivel de cada Job quedó como provisional.

4. Mapa de mercado

Competidores directos en Chile

- **Meedika.** App chilena lanzada el 25 de septiembre de 2024 en App Store, con Android previsto semanas después. Reportó más de 1.500 usuarios en los primeros días y una meta de 32.000 usuarios a corto plazo (declaración del cofundador). Su estado actual no se pudo verificar.
- **Infomed.** App chilena lanzada en marzo de 2021 con 1.200 usuarios. Planeaba un relanzamiento en julio de 2021 y una ronda de US\$ 500 mil. Su estado actual no se pudo verificar.
- **Apps de clínicas.** Por ejemplo, la app de Clínica Alemana de Valdivia permite reservar hora, ver el historial de consultas en esa institución y vincular a un familiar. Son gratuitas y cubren solo la propia institución.

Competidores regionales

- **MediPlanner** (listada en la App Store de México): historial, alergias, vacunas, perfiles familiares, recetas digitales y compartir con profesionales. Gratuita.
- **Clingot** (Argentina): app para cargar antecedentes médicos propios; la nota que la describe no tiene fecha verificada.

Sustitutos

- Fotos en el celular y papeles en casa. La alternativa más común, según el propio planteamiento del problema.
- Solicitar copia de la ficha a cada institución. Un blog de proveedor (AgendaPro) indica que Fonasa no tiene un historial centralizado y que se accede por establecimiento; es una fuente comercial, no oficial.

Adyacentes

- **Apple Health Records:** agrega registros clínicos usando el estándar FHIR; en 2018 se reportaban más de 500 hospitales y clínicas conectados, y no encontré evidencia de disponibilidad en Chile.
- **ChatGPT Health (7 de enero de 2026) y Claude for Healthcare (11 de enero de 2026):** permiten conectar registros médicos, con conectores que hoy operan solo en Estados Unidos. Nota de transparencia: Claude for Healthcare es un producto de Anthropic, la empresa que desarrolla a Claude, el modelo que redactó este informe.

Blockchain y salud

- **Medicalchain** (Londres, 2017, Ethereum): etapa piloto según un registro de la Comisión Europea de 2020.

- **Patientory** (Atlanta): levantó US\$ 7,2 millones mediante financiamiento cripto; ya en su momento se advertía que los hospitales podían resistirse a que el paciente pudiera llevarse su información.
- **MedBlock** y marcos académicos (como HealthChain). Ninguno con adopción verificada.

5. Inteligencia de funcionalidades

- **Meedika:** gestión de documentos, importación de solicitudes, un apartado SOS con datos críticos (alergias, medicación), calendario de citas, recordatorios de medicamentos y sincronización de resultados desde centros de salud. Escenario: paciente que reúne y comparte su historial. Limitación conocida: la fuente es una nota de prensa con declaraciones del cofundador, sin prueba independiente de las funciones.
- **MediPlanner:** historial por perfil familiar, vacunas y alergias, gráficas de evolución y agendamiento. Escenario: cuidado familiar. Limitación: aplicación listada en México; sin evidencia de uso en Chile.
- **App de clínica:** consulta de historial dentro de una institución. Limitación: no reúne datos de otras instituciones.
- **Apple Health Records y asistentes de IA:** agregan registros vía FHIR y proveedores de conexión (b.well, HealthEx). Limitación: dependen de redes de proveedores estadounidenses.

Todo esto proviene de descripciones comerciales y notas de prensa. No se probó ninguna de las apps.

6. Señales de la comunidad y del regulador

Señales de que el problema existe

- Resoluciones de la Superintendencia de Salud (2025-2026) sobre sanciones a agentes de ventas de ISAPRE por omitir o inducir a omitir preexistencias en la Declaración de Salud. En los casos revisados hubo exclusión de cobertura o término de contrato.
- Un fallo de la Corte Suprema (reportado en agosto de 2025) resolvió que una ISAPRE no podía reducir cobertura por una condición que el afiliado nunca había sido diagnosticado como tener.
- Una guía legal chilena califica de burocrático el proceso de pedir la ficha clínica, y SUSESO aclara que se entrega el contenido de la ficha, no el soporte material, que las instituciones conservan 15 años.
- Declaración de marketing, no verificada: MediPlanner afirma que entre el 40% y el 80% de lo que dice un médico se olvida al salir de la consulta.

Lo que no encontré

- Hilos de foros, reseñas de usuarios o comentarios en redes sociales sobre este problema en Chile. La evidencia de dolor del usuario es indirecta (regulador, jurisprudencia y declaraciones de fundadores). Es una brecha para cerrar con entrevistas.

7. Tendencias

1. **Asistentes de IA con acceso a registros médicos** (enero de 2026). Fija la expectativa de que el historial pueda consultarse y resumirse. Fuerza de la señal: alta a nivel global; todavía sin presencia comprobada en Chile. Riesgo señalado por analistas: concentrar registros médicos en plataformas de consumo aumenta la superficie de ataque.

2. **Regulación chilena.** La Ley 21.668 (interoperabilidad de fichas) sigue a la espera de su reglamento, y la Ley 21.719 (datos personales) entra en vigencia plena el 1 de diciembre de 2026. Ambos puntos se verificaron en la investigación previa de esta conversación. El MINSAL ya publica guías de implementación, incluido un resumen clínico del paciente (IPS-CL).
3. **Conectividad.** Unos 22,6 millones de accesos móviles (3G, 4G y 5G) a mediados de 2026 y 96,5% de los hogares con acceso a internet en 2024.
4. **Carga de enfermedad crónica y envejecimiento.** La Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 estimó 27,6% de hipertensión, 12,3% de diabetes tipo 2 y 18,6% de sospecha de hipotiroidismo (clínico confirmado: 2,2%, con un tercio sin saber que lo tiene según SOCHED). Un 12% de la población tiene más de 65 años.
5. **Cambio del sistema de seguros.** Entre enero de 2022 y junio de 2025 migraron 892.414 personas de ISAPRE a Fonasa. A enero de 2026, Fonasa tenía 17,1 millones de beneficiarios (85% de la población) y las ISAPREs unos 2,5 millones.

Escenarios (probabilidades subjetivas, confianza baja)

- El MINSAL publica un reglamento con plataforma o estándar central y acceso del paciente por canal oficial: 25-40%.
- El reglamento se demora y persiste la fragmentación, con apps privadas compitiendo: 40-55%.
- Asistentes de IA con conectores de registros llegan a Chile: 10-20%.

8. Jobs y segmentos (AJTBD)

Estado de la validación. El agente validador exige el canon de Zamesin en disco y no está instalado, así que devuelve CANON UNAVAILABLE. Apliqué manualmente las reglas de gramática del flujo (Quiero + un infinitivo, sin formato «Cuando... quiero... para...»). Esto no equivale a una validación contra el canon. Los niveles son provisionales porque no hay perfil.

Jerarquía de Jobs (provisional)

- **Big Job:** Quiero cuidar mi salud a largo plazo.
- **Core Job (el producto lo cumple por completo):** Quiero tener mi historial de salud completo a mano.
- **Small Jobs (hermanos del Core, no cubiertos):** Quiero agendar horas médicas; Quiero entender mis resultados; Quiero tomar mis medicamentos a tiempo.
- **Micro Jobs:** Quiero subir mis documentos médicos; Quiero recordar mis alergias; Quiero compartir mi historial con un médico; Quiero declarar mis preexistencias a una aseguradora.

Segmentos (hipótesis, sin investigación primaria)

- **S1: personas con condiciones crónicas o varios prestadores.** Muchas consultas, documentos dispersos y riesgo clínico por omitir antecedentes. Respaldo: prevalencias de la ENS. Prioridad: alta (frecuencia y dolor).
- **S2: cuidadores de hijos o padres mayores.** Gestionan el historial de otros; exige resolver representación y consentimiento. Respaldo: apps que ya ofrecen perfiles familiares. Prioridad: media (multiplica el valor, complica lo legal).

- **S3: personas que contratan o cambian de ISAPRE.** Dolor agudo (pérdida de cobertura por omitir preexistencias), pero el segmento es acotado y se está reduciendo por la migración a Fonasa. Riesgo adicional: una herramienta que facilita probar el historial podría usarse en contra del paciente. Prioridad: baja a media.

La priorización es mi juicio sobre la evidencia disponible; no se midió.

9. Oportunidad de mercado y ROI

Embudo (cinco filtros)

1. Población residente: 18,48 millones (Censo 2024; la proyección del INE usada por la Superintendencia es 20,1 millones).
2. Adultos: unos 14,4 millones (supuesto: 78% de la población, sin fuente; verificar con el INE).
3. Con acceso a internet: unos 13,9 millones (96,5% de los hogares, 2024).
4. Con hipertensión, como cota inferior de personas con condición crónica: unos 3,8 millones (27,6%, datos de 2016-2017, probablemente hoy más altos).
5. Usuarios alcanzables en tres años: ver abajo.

TAM, SAM y SOM

- **TAM (usuarios potenciales):** unos 13,9 millones de adultos con acceso a internet.
- **SAM:** unos 3,8 millones de adultos con hipertensión.
- **SOM (top-down):** 1% a 3% del SAM, es decir, entre 38 mil y 115 mil usuarios a tres años.
- **SOM (bottom-up, con referencias de competidores):** Infomed llegó a 1.200 usuarios; Meedika declaró una meta de 32.000. Eso respalda un rango de miles a pocas decenas de miles.
- **Reconciliación:** el techo top-down supera entre 1,2 y 3,6 veces la meta de Meedika. Conviene tomar unos 30-40 mil como caso base y 115 mil como escenario optimista, condicionado a tener distribución.

Precios de referencia

- Clínica Alemana de Valdivia (app): gratis.
- MediPlanner: gratis en la App Store de México.
- Apple Health: incluida en el dispositivo.
- ChatGPT Health y Claude for Healthcare: dentro de planes de suscripción del asistente (Claude, solo Pro y Max en Estados Unidos); no verifiqué precios actuales.
- Meedika: precio no encontrado.
- Conclusión: lo habitual es gratis para el paciente, lo que sugiere baja disposición a pagar. No hay datos propios que lo confirmen.

Potencial económico (ilustrativo, todos los supuestos sin validar)

- Supuesto: 10% de los usuarios paga US\$ 30 al año.
- Caso base (38 mil usuarios): unos 3.800 pagadores, es decir, cerca de US\$ 114 mil por año.
- Escenario optimista (115 mil usuarios): unos 11.500 pagadores, cerca de US\$ 345 mil por año.

- Techo teórico con los mismos supuestos: unos US\$ 11,5 millones por año si se captara todo el SAM, y unos US\$ 41,7 millones si se captara todo el TAM. Son referencias de tamaño, no proyecciones.
- **ROI:** no se calculó. Faltan costos de desarrollo, adquisición, cumplimiento (evaluación de impacto bajo la Ley 21.719, seguridad) y operación.

Segmentos en cuatro dimensiones (juicio cualitativo)

- **S1:** mercado grande (millones), valor por cliente medio, rentabilidad incierta (disposición a pagar baja), escalabilidad alta.
- **S2:** mercado medio, valor por cliente medio a alto, rentabilidad incierta, escalabilidad media por la complejidad legal.
- **S3:** mercado acotado y decreciente, valor por cliente alto pero concentrado en un momento (la contratación), rentabilidad posible vía convenio con aseguradoras o asesores, escalabilidad baja y con riesgo reputacional.

Lectura estratégica: la suscripción directa del paciente rinde poco. Un negocio viable probablemente dependa de otra fuente de ingresos (convenios con prestadores, empleadores o aseguradoras), lo que choca con el principio de que el paciente controla sus datos. Es una tensión de diseño que hay que resolver antes de construir.

10. Calidad de la investigación, brechas y riesgos

Alertas

- **Brecha de evidencia:** no hay investigación primaria ni señales directas de usuarios; los precios de Meedika y el estado actual de Meedika e Infomed son desconocidos.
- **Brecha de cobertura:** no se probó ningún producto; las funciones provienen de descripciones comerciales.
- **Riesgo de supuestos:** el porcentaje de adultos (78%), la proporción de pagadores (10%) y el precio (US\$ 30) no tienen fuente. Los datos de prevalencia son de 2016-2017.
- **Fuentes de calidad variable:** parte del contexto proviene de blogs de proveedores y notas de prensa con declaraciones de los fundadores.
- **No evaluado:** ajuste estratégico (sin perfil) y validación contra el canon AJTBD (no disponible).
- **Riesgo de producto:** una herramienta de historial puede ayudar a las aseguradoras a seleccionar riesgo si no se diseña con límites claros; la regulación de software médico para las etapas C y D no se verificó.

Veredicto: la investigación sirve para decidir qué validar a continuación, no para comprometer inversión. Falta confirmar con usuarios que el problema duele lo suficiente y que el producto se diferencia de Meedika.

Revisión de calidad del informe (autorevisión): no detecté afirmaciones sin respaldo de severidad alta ni contradicciones críticas entre secciones. Los puntos de severidad media son los supuestos del embudo y de ingresos, marcados como tales en el texto.

11. Recomendaciones y próximos pasos

1. **Probar Meedika** (y las apps de clínicas) para documentar funciones reales, precios y reseñas.
2. **Entrevistar de 15 a 20 personas** de S1 y S2 sobre cómo guardan hoy su historial, qué olvidaron decir en consulta y qué consecuencias tuvo.
3. **Decidir el modelo de negocio** antes de construir: ¿suscripción directa, convenios con prestadores o empleadores, o modelo mixto?
4. **Definir el diferenciador frente a Meedika**, por ejemplo documentos con respaldo verificable de la institución emisora, divulgación selectiva y antecedentes familiares. Son hipótesis a validar.
5. **Validar con un abogado** especialista en datos personales y salud: Ley 21.719, representación de familiares y límites de uso por aseguradoras.
6. **Revisar la guía IPS-CL del MINSAL** y seguir la publicación del reglamento de la Ley 21.668.
7. **Decidir cuándo incorporar Midnight**: solo si el piloto muestra que la divulgación selectiva aporta más valor que compartir un documento.
8. **Completar el flujo**: instalar el canon AJTBD y armar el perfil de empresa para repetir los pasos 5 a 7 con validación completa.

Fuentes consultadas

- Meedika (Diario Estrategia, 12 de noviembre de 2024): diarioestrategia.cl/texto-diario/mostrar/5067089/meedika-aplicacion-chilena-gestiona-informacion-medica-usuarios
- Infomed (DF, 25 de junio de 2021): df.cl/df-lab/transformacion-digital/infomed-la-app-para-llevar-el-historial-medico-en-el-celular-lanzara
- App de Clínica Alemana de Valdivia y MediPlanner (App Store).
- Apple Health Records (Healthcare IT News y Healthcare Dive, 2018).
- ChatGPT Health y Claude for Healthcare (HLTH, 3 de febrero de 2026; EBG Health Law Advisor; MobiHealthNews).
- Medicalchain (Knowledge4Policy, Comisión Europea); Patientory (MassDevice; Medical Design and Outsourcing).
- Superintendencia de Salud: resoluciones exentas de 2025-2026 sobre declaraciones de salud; presentación de cuenta pública 2026; análisis de ISAPRE 2025. Fallo de la Corte Suprema (Diario Constitucional, 28 de agosto de 2025).
- SUSESO, dictámenes 1172-2015 y 23914-2014; guía de Águila y Cía. sobre ficha clínica; blog de AgendaPro.
- Fonasa y ISAPRE: Radio U. de Chile (4 de marzo de 2026); La Tercera (2025); MINSAL (presentación de agosto de 2025).
- Subtel (informes 2025); Pulso (5 de febrero de 2025); Mobile Time.
- Encuesta Nacional de Salud 2016-2017: Ars Medica; MINSAL (hipotiroidismo); 24horas.cl (SOCHED).